目前個管員 212 位，列管量為 2 萬 7,897 案，平均每位個管員管案量 132 案。

B. 業務目標與推展規劃

① 派案機制

為落實個案管理，且使個案獲得最專業、最完善的照護，本市訂有「臺南市政府社會局社區整合型服務中心派案原則」，本市照管專員以全派案 A 單位為原則。

- A 單位應秉持個案管理之核心、公平派案，並以案家選擇之 B 單位為最優先派案；其次為依照派案輪序機制派案、並存有指派或輪派之紀錄，每個月呈送照顧專員備查。
- 若 B 單位有持續未能提供服務之情形，得轉派其他單位、減少或暫停派案；倘 B 單位經多次輔導或規勸未果，應回報照管中心。
- 本市督請 A 單位依本市社區整合型服務中心派案原則公布派案情形，加強派案資訊透明化，相關輪派順序 A 單位應於轄區聯繫會議公開輪派順序，並做成會議記錄供 B 單位參閱；每月報表呈現各項服務輪派狀況並於公佈於本市長期照顧管理中心網頁。

② 照顧計畫擬定作業時效

個管員與照顧專員共訪後，3 天內擬定照顧計畫俟簽審後於 2 天內照會給 B 單位，B 單位收到照會後 3 天內提供服務，期待 7 天內完成服務輸送流程。

③ 服務輸送流程等之改善策略

透過個管員針對個案需求性擬定個別化照顧計畫，並定期追蹤個案長照服務使用情形，強化以個案為中心的整合服務，同時減輕照顧者照顧壓力。

④ 品管指標執行

訂有「臺南市社會局辦理社區整合型服務中心(A 級單位)品質管控機制實施計畫」，於每年進行 A 單位業務輔導查核、每區每季進行個案管理人員服務紀錄線上抽查，另每年至少實地查核 1 次。

⑤ 年度業務聯繫會議等之規劃

為與 A 單位建立良好橋樑，每年辦理兩場聯繫會議，以達成雙方意見交流之目的。

⑥ 預期服務績效

透過個管員至案家與長照需要者或其家屬討論，量身制訂符合個案之照顧計畫，藉由長照服務的介入，減輕照顧者壓力，並使個案能獲得更妥適的照顧。

C. 個案服務品質查核機制

訂有「臺南市社會局辦理社區整合型服務中心(A 級單位)品質管控機制實施計畫」，針對 A 單位派案 B 單位情形進行查核，每年度抽查轄內每個 A 單位在案量至少 1%，如屬 A 單位派案同一或關聯之 B 單位且屬 A 單位派案量前三名者，則進行在案量 10%抽查作業。經查有異常情事者造冊後，函送服務單位依限回覆改善情形及提出相應改善方案及策進作為。

D. 提升 A 單位轉介多元服務情形

本市依據「臺南市政府社會局長期照顧專業服務推廣計畫」獎勵制度實施，專業服務使用人數達年度總案量的 7%，可於評鑑時增加總分 2

分，若達到 10%再額外增加 1 分，最高可獲得 3 分（列於 A 單位評鑑指標額外加分項目）。

E. 因應多元新興議題提升 A 個管專業識能規劃

將於 A 單位契約中規範每單位每年針對 A 個管辦理教育訓練，訓練課程應包含身障、失智、家庭照顧者等面向。

II. 巷弄長照站（C）

A. 服務資源布建規劃

截至 111 年 8 月為 205 個巷弄長照站，服務範圍包含本市 37 區，涵蓋率為 100%。

因應衛生福利部 108 年整合社區照顧關懷據點及 C 級巷弄長照站政策，以齊一窗口為目標盤整所轄據點及 C 單位，積極輔導單位轉型辦理，以落實社區照顧、在地安老之理念；111 年持續督導單位提升服務量能及品質，並依中央規範輔導醫事 C 單位強化社區照顧關懷服務，全面優化 C 級巷弄長照站服務成效。

為維護服務品質，112 年預計新增 1 單位提供巷弄長照站服務，全市共 206 家服務提供單位。

B. 預防及延緩失能照護服務推動規劃

① 配合衛福部指定之資訊平台，進行資料建置與登錄，並督導巷弄長照站確實完成資料登錄，掌握社區個案服務情形。

② 加強服務品質監測，透過實地查核及召開聯繫會議等，確保服務品質及達到雙向溝通目的。

③ 配合中央進行之既有模組方案盤整政策，持續執行通過方案師資人才監管機制。

C. 實名制報到推動情形。

① 110年起依中央實名制政策規劃，已於業務聯繫會報宣達並操作教學，且由社區輔導員第一線輔導，協處困難疑義，並持續依系統公告滾動修正。

② 輔導單位完成實名制切結書。

（9） 長照專業服務

I. 推動管理之具體目標及策略

A. 提升服務使用率

① 本市自110年5月起，辦理專業服務推廣計畫，冀望藉以獎勵 A 單位評鑑加分機制，提高連結專業服務使用率。請 A 單位個管員依個案照顧問題清單需求連結專業服務，並以低收入戶為優先推廣對象，藉由免部分負擔金額，提升個案使用意願。

② 將長期照顧專業人員數位學習平台「復能服務基本概念」課程，列入本市長期照顧管理中心新進照顧管理專員培訓課程，並建議 A 單位個管員自主學習，經提升對復能服務的認知，讓照專與 A 個管於洽談服務項目時，可以更清楚向個案與案家屬說明使用專業服務對個案的助益。

③ 跨項目長照服務合作：協調提供服務使用者居家服務之照顧服務員，結合專業服務治療師提供復能指導訓練，以落實專業照護技巧之普及。

B. 持續佈建特約單位

截至 111 年 8 月止特約有 70 家專業服務提供單位，服務範圍包含本市 37 區，涵蓋率為 100%；112 年預計佈建 8 家服務提供單位，全市將達 82 家服務提供單位。

C. 111 年 1 月至 8 月底止，歸戶服務人數為 5,037 人，其中女性佔 2,890 人、男性佔 2,147 人；累計服務 1 萬 3,420 人次

II. 偏遠地區（原住民族、離島及其他資源不足區）服務推動之鼓勵措施

A. 本市偏遠地區至 111 年 8 月底計有 1 家特約單位，服務範圍為本市龍崎區。另設立於其他區域之服務提供單位仍可支援至偏區服務。

B. 111 年 1 月至 8 月底止，偏遠地區服務人數為 85 人，其中女性佔 44 人、男性佔 41 人；累計服務 282 人次。

III. 服務品質管理

A. 訂有臺南市長照復能注意事項，服務單位須依規定進行辦理，維持各單位提供服務之基準。

B. 每月不定時對服務個案進行抽查，每年對特約單位進行輔導查核，督導其服務執行狀況並審查是否依法規及規定辦理

截止至 111 年 8 月查核異常情形，查有部分負擔收據誤繕、未蓋機構印信、費用收錯或向個案額外收取交通費等情況，已令單位改善並返還相關費用予個案。行政管理中部分單位未對個案進行收案管理；在人力管理上查有未依規定進行報備支援作業，或專業人力在服務後，因個案尚未結案，而未將資料歸至特約單位中。

C. 本市專業服務審查機制包含「6 歲以上長照專業服務延案審查」及「0 至 5 歲長照專業服務審查會議」:

① 6歲以上長照專業服務延案審查

採縣市主管機關與社區整合型服務中心共同審查機制。經服務單位填具延案評估欄位表單，敘明提交延案申請原因、服務現況及預期效益後，交由 A 單位個管員及照管專員審閱及填具延案建議，再送本市延案審查小組，針對該個案服務計畫書及服務紀錄進行延案審查。

② 0至5歲長照專業服務審查會議

係採縣市主管機關邀集專業單位共同審查方式辦理，其成員包括本市長期照顧管理中心照專督導及照管專員、醫療及醫事相關團體及學者、A 單位個管員共同審查。考量長照個案使用專業服務的合理性及服務效益，經盤點個案現有的正式及非正式資源，藉以釐清個案宜使用醫療復健資源，抑或經專業服務提供適切性的介入服務。

IV. 服務推動之困難、限制

有關照顧管理服務資訊平臺－專業服務目標之設定，若欲修正需提送資料予中央承辦人，協請系統工程師進行修正，影響行政效率。雖已製作詳細操作說明提供給本市 A 單位，加強人力管理，惟仍會有操作錯誤而未能及時更正之情形發生。

V. 因應措施及策進作為

建請中央調整專業服務目標管理設定，並提供縣市承辦人修正權限及放寬暫存下可修正的項目內容。

（10） 喘息服務

I. 執行規劃及策略

A. 為提供服務個案充足服務量能，規劃與所有居家式及社區式長照機構簽訂喘息服務特約，以建立完整的喘息服務資源；同時關注各項喘息服務使用需求，並維持服務品質。

B. 本市 110 年底特約有 263 家喘息服務提供單位，至 111 年 8 月已成長達 312 家喘息服務提供單位（各喘息類型累計計算單位數為 331 家），服務

範圍包含本市 37 區，鄉鎮市區涵蓋率為 100%；預計 112 年特約單位將成長至 340 家。

C. 111 年 1 月至 8 月底止，歸戶服務人數為 7,837 人，其中女性佔 4,794 人、男性佔 3,043 人；累計服務 11 萬 9,657 人次。

II. 偏遠地區（原住民族、離島及其他資源不足區）服務推動之鼓勵措施

A. 對於偏遠地區服務服務推動，於各大會議，如：社區照顧關懷據點每季聯繫會議、區村里幹事、里長會議、志工會議等宣導長照服務內容，讓偏遠地區民眾進而了解喘息服務，並鼓勵有需求之民眾提出申請，以減輕照顧負擔。

B. 本市偏遠地區至 111 年 8 月底計有 3 家特約單位，服務範圍為本市南化區、左鎮區、楠西區。截至 111 年 1 月至 8 月底止，偏區歸戶服務人數為 63 人，其中女性佔 44 人、男性佔 19 人；累計服務 866 人次。

C. 另截至 111 年 8 月底，長照喘息服務派案可服務人數為 288 人，實際使用人數為 147 人，喘息服務涵蓋率為 51%。

III. 服務品質管理

截至 111 年 8 月底至衛生福利部照顧管理資訊平台進行個案服務紀錄抽查，查核照會與申報之服務紀錄是否相符，已抽查 2,782 筆服務紀錄；另依臺南市政府社會局特約長期照顧喘息服務輔導查核計畫，針對業務內容進行實地督導查核，已查核 30 家喘息服務單位。

IV. 困難及限制

本市使用喘息服務量逐年上升，尤其居家喘息服務使用人次佔所有喘息服務約 8 成的使用率，但使用社區式喘息服務相對較少。

V. 因應措施及策進作為

為提升社區式、巷弄喘息服務量能，積極與社區式長照機構及巷弄長照站簽訂喘息服務特約，對於主動洽詢單位，主動提供喘息服務契約及特約申請表單，輔導單位特約申請並針對契約內容重點提醒，以利後續服務提供。

另請照顧管理專員推廣服務使用者使用社區式喘息服務，提升社區式喘息服務使用率。

4. 長照住宿式服務機構

（1） 執行規劃及策略

I. 截至 111 年 8 月底，全市共 213 家長照住宿式機構資源（含老人福利機構 117 家、提供住宿式服務之身心障礙福利機構 16 家、一般護理之家 77 家、精神護理機構 3 家及榮譽國民之家 3 家），共可服務 1 萬 4,467 人，實際服務 1 萬 2,129 人（老人福利機構 4,900 人、身障福利機構 1,144 人、精神護理之家 174 人、一般護理之家 5,464 人及榮譽國民之家 447 人），區域涵蓋率 91.89%。

II. 設立中機構

本市老人福利機構 112 年預計新設立 2 家(玉井區 95 床)，114 年預計新設立 1 家(楠西區 95 床)。

住宿式服務類長期照顧服務機構 112 年預計新設立 1 家（北門區 97 床），另有 6 家機構已取得籌設許可。

序號	機構名稱	床位數	行政區	目前進度	預計時間
1	臺南市私立宜璞安養中心	46 床	玉井區	興建中	需於 112 年 4 月 15 日前完

					成設立
2	臺南市私立璞緣安養中心	49床	玉井區	興建中	需於112年6月8日前完成設立
3	臺南市私立長春老人長期照顧中心(養護型)	49床	楠西區	辦理用地變更編定中	預計於114年完成設立
4	玉山長照社團法人附設臺南市私立玉山住宿長照機構	49床	山上區	興建中	110年6月4日許可籌設
5	永康慈善長照社團法人附設臺南市私立永康慈善住宿長照機構	90床	永康區	興建中	110年8月5日許可籌設
6	成功長照社團法人附設臺南市私立晶泰綜合長照機構	100	安南區	興建中	110年10月28日許可籌設
7	宜福長照社團法人附設臺南市私立宜福住宿長照機構	145	歸仁區	興建中	111年1月28日許可籌設
8	香格里拉長照社團法人附設臺南市私立香格里拉住宿長照機構	173	東山區	興建中	111年3月8日許可籌設
9	喬安長照社團法人附設臺南市私立永安住宿長照機構	160	安南區	興建中	111年5月16日許可籌設
10	臺南市政府社會局附設北門綜合長照機構(委託台灣元氣村長照社團法人	97	北門區	申請設立	111年9月15日許可籌設

III. 規劃中機構

本市及4家部立醫院自行申請衛生福利部獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫及醫院轉型案，分別為下：

A. 六甲區：本府規劃100床。
B. 新市區：衛生福利部胸腔病院規劃200床。
C. 柳營區：衛生福利部新營醫院規劃100床。
D. 玉井區：衛生福利部臺南醫院規劃100床。
E. 安定區：衛生福利部嘉南療養院規劃200床。

（2） 偏遠地區（原住民族、離島及其他資源不足區）服務推動之鼓勵措施

本市偏遠地區為楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區，目前楠西區有 1 家老人福利機構籌設，可服務 49 床，以及 2 家全日型住宿式身心障礙福利機構，分別位於左鎮區、龍崎區，可服務人數計 196 人，實際服務人數計 188 人，服務使用率達 95.9%。

（3） 服務品質管理

I. 老人福利機構

A. 機構抽查：111 年 1 月至 8 月底，共計完成 114 家次抽查(含防疫查核、聯合稽查、輔導等)。

B. 機構評鑑：111 年 3 月至 8 月至本市私立小型老人福利機構辦理丙丁等機構輔導及複評，受輔導及複評家數共計 11 家。

C. 住宿式服務機構品質提升卓越計畫：111 年 8 月底輔導本市轄內 71 家老人福利機構申請「住宿式服務機構品質提升卓越計畫」,並透過教育訓練、遠距輔導等協助機構通過品質指標之評核，經審核通過者給予獎勵費。

D. 老人福利機構小型公安獎助計畫：111 核定獎助本市轄內老人福利機構申請「小型公安獎助計畫」共 79 家次，並輔導經審核通過者裝設 119 火災通報系統、電路汰換、寢室隔間與樓板密接整修、自動撒水設備，截至 111 年 9 月 20 日，已完成施作共 43 家次。

II. 身心障礙福利機構

A. 評鑑機制

① 配合中央辦理機構評鑑，工作事項包括：協助彙整、審核及提報轄內受評機構自評報告相關資料電子檔;派員協助實地訪評委員就機構受評項目、平時受輔導及經營管理狀況提供必要之資料與諮詢;就授權主管機關之指標進行評分。

② 評鑑指標包括行政組織及經營管理、環境設施及安全維護、專業服務、權益保障、改進及創新措施五大面向。評鑑成績優等者予以獎勵，丙等或丁等者應接受本局輔導並積極改善。

B. 輔導機制

① 平日輔導每年至少查核2次；其中全年度至少1次各局處聯合稽查。

② 查核發現有違反法令規定之缺失，依身權法規定限期機構改善，令機構限期改善期間，不得增加服務身心障礙者；針對查核發現缺失事項，訂定輔導改善策略或追蹤輔導其改善情形,並按時將輔導查核情形季報表及年報表報送衛生福利部社會及家庭署。

III. 一般護理之家、精神護理之家

① 每上下半年各辦理本市護理機構平時輔導訪查1次。

② 不定期稽查轄內一般護理之家，依法進行輔導及裁處。

③ 依護理人員法每年辦理一般護理之家督導考核。

（4） 困難及限制

長照住宿式服務機構因涉及長照機構法人設立、機構籌設、設立等階段，單位對於辦理流程與相關法規易因不熟悉，致申辦期程拉長之情形。

（5） 因應措施及策進作為

本府社會局已於官網成立長照機構法人及長照機構申設專區，提供長照相關法規、長照法人申請作業須知及書表、長照機構申設流程，供下載參考。

5. 居家失能個案家庭醫師照護方案

（1） 執行規劃及策略

I. 本市 110 年底特約有 35 家居家醫師服務提供單位，醫師 44 人，至 111 年 8 月特約 42 家居家醫師服務提供單位，醫師 56 人，目前服務範圍包含本市 37 區，鄉鎮市區涵蓋率為 100%。

II. 111 年 1 月至 8 月底止，歸戶服務人數為 3,273 人，其中女性佔 1,962 人、男性佔 1,311 人；累計服務 2 萬 255 人次。

III. 112 年持續進行業務宣傳，針對在地服務資源較不足或服務個案高之行政區，積極提高服務單位數，並持續發掘在地長照需求者，進行長照資源的媒合，以提升服務使用人數。

另一方面建立A個管、照管專員、服務單位橫向資源溝通連結機制，規劃於各區 A 單位定期聯繫會議中邀請家庭醫師服務單位、照專進行個案報告討論。針對特殊個案由業務承辦人員協助建立 A 個管、照專、醫師共同聯繫討論組群，以達橫向連結之效果。

（2） 服務品質管理

服務品質以抽查及輔導機制管理，抽查項目包括服務時效、居家醫師意見書完整度。時效部分於每月固定 10 日經衛生福利部照顧服務管理資訊平台產製上個月時效報表，共已抽查 8 次，檢視各單位家訪時效情形，了解特約單位無法於 14 日內完成家訪之原因，予協助輔導單位轉由其他單位收案。

居家醫師意見書完整度部分，採每家服務單位每月至少抽查 10%服務案件數,111 年 1 至 8 月共已抽查 152 案,檢視醫師意見書之內容完整度、相關建議。遇醫師意見書之內容完整度較欠缺之情形，由業務承辦人員個別通知醫師與其討論及說明。針對該年度新特約之單位，安排至少 1 場實地輔導，提供衛生福利部照顧管理資訊平台操作流程說明，並向醫師說明居家醫師意見書登打重點摘要。

（3） 困難及限制

I. 衛生福利部照顧服務管理資訊平台於 110 年度系統改版時，將派案 mail 提醒通知特約單位之功能取消，造成特約單位不便，易延遲或遺漏案件。另結案無法與結束服務同步，時常結案後，單位狀態仍為服務中。

II. 醫師登打醫師意見書時，會先於衛生福利部照顧服務管理資訊平台，新增基本資料詳細內容會於家訪後才完成登打,但因平台只有儲存鍵無暫存功能鍵，導致 A 個管人員、照專所見為空白意見書易產生誤會。

III. 醫療院所醫療業務重無特約意願，且鄉村型行政區在地醫療資源少，服務資源家數不易增加。

IV. 此計畫主要提供個案長照及慢性病的建議,但個案平常就有固定性回診或習慣就診醫生，家屬及個案多拒絕使用服務，導致服務使用率提升不易。

（4） 因應措施及策進作為

I. 照管平台系統之意見彙整提供長照司承辦人，並協請照管專員協助通知服務單位，以利派案通知、結案與結束服務的掌控。

II. 目前在地服務單位不足之區域,目前協調其他區域之單位提供跨區服務；且已於長期照顧推動小組111年第2次會議提案討論上建請衛生局針對在地量能不足區域，鼓勵其轄下衛生所加入本方案，其他區域也持續尋找有意願加入計畫之單位，進行業務計畫說明。

III. 目前仍持續進行業務宣傳,針對在地服務資源較不足或服務個案高之行政區,積極提高服務單位數,並持續發掘在地長照需求者,進行長照資源的媒合,以提升服務使用人數。

6. 中低收入失能老人機構公費安置

(1) 執行規劃及策略

I. 本府111年補助家庭總收入按全家人口平均分配,每人每月未達社會救助法規定最低生活費1.5倍之重度失能老人,或經評估確有進住機構必要之中度失能老人機構安置費標準為每人每月2萬2,000元(金額依實際情形修正),依行政院主計總處最新公告「各直轄市及縣(市)政府財力分級表」,本府財力分級列為第3級(級別依實際情形修正),爰以每人每月2萬2,000元安置費為基準,申請長照服務發展基金補助每人每月5,200元(金額依實際情形修正)。本案原預計補助1,079人,目前實際補助1,128人,達成率105%。

II. 機構服務資源部分已簽訂140家,預計112年共獎助1,406名低收入戶及中低收入重度及中度失能老人,分別如下:

A. 獎助1,110名家庭總收入按全家人口平均分配,每人每月未達社會救助法規定最低生活費1.5倍之重度失能老人。

B. 獎助292名最低生活費1倍以下之中度失能老人且經評估確有進住機構需求者。

C. 補助1名超過最低生活費1倍、未達最低生活費1.5倍之中度失能老人,且經評估家庭支持情形,確有進住必要者。

D. 補助3名年滿五十五歲以上至六十四歲以下每人每月未達社會救助法規定最低生活費 1.5 倍原住民,且失能等級七級以上者之重度失能者。

(2) 困難及限制

I. 衛生福利部長照服務發展基金獎助財團法人附設老人福利機構各項經費(服務費、修繕費、公共安全設施設備費及充實設施設備費),每年補助約新臺幣百萬元不等,財團法人附設老人福利機構卻不願意配合縣市政府收容公費安置個案。

II. 目前因外籍看護工短缺,部分家庭轉而將家中失能長輩送至機構接受照顧,導致公費安置個案入住機構困難度增加。

(3) 因應措施及策進作為

I. 建請衛生福利部社會及家庭署研議財團法人附設老人福利機構補助方案,能將收容公費安置人數納入補助標準,收容人數越多提高補助金額,反之不願意配合收容公費安置個案之財團法人附設老人福利機構不予補助。

II. 有關中低收入失能老人機構公費安置,長照服務發展基金獎助每人每月5,200元(其中1,000元縣市政府免自籌款),建請衛生福利部社會及家庭署能將縣市政府免自籌款1,000元提高至2,000元。

(4) 112年度經費需求:本府自籌經費編列2億8,344萬9,600元;申請長照服務發展基金獎助8,773萬4,400元。

7. 出院準備銜接長照服務

(1) 推動管理之具體目標及策略

I. 111 年計有 25 家合作醫院，參與醫院涵蓋率達 81%，預計 112 年涵蓋率持平。

II. 業務目標與推展規劃

A. 辦理業務聯繫會議，作為提供合作之醫院針對計畫執行與合作模式良好溝通平台。

B. 與出備銜接長照服務醫院合作，依服務流程協助由醫院評估人員完成長照需求評估個案之服務核定與資源連結。

C. 辦理評估人員訓練及持續輔導，以維持服務品質。

D. 透過與醫院合作辦理宣導或教育訓練，提升服務能見度及人員專業知能。

E. 針對本市出備醫院藉由查核機制，評估其執行績效並輔導執行。

（2） 服務品質管理

由派案督導於系統查核評估內容一致性，若發現單位有評估錯誤或不一致，後續安排負責轄區進行評估人員輔導，針對評估及系統操作再訓練及回覆示教，並追蹤其評估狀況，以確保品質；針對每間出備醫院不定期進行實地稽核並輔導醫院執行。

（3） 困難及限制

部份出備評估人員因人力流動及評估經驗不足，導致使用照顧管理評估量表（繁表）評估之操作不熟悉，會影響長照個案需求問題及後續連結之服務資源。

（4） 因應措施及策進作為

針對評估人員應完成之課程訓練，實體課程採每場次不超過 5 人，由照管專員單獨指導 3 名個案實例演練，採取人數較少，甚至一對一的互動指導方式，希望能讓受訓者有充分時間可以吸收及發問，以提高訓練效果；經查核有異常情事者，本局製成異常事件書面報告，單位需於十五日內說明並函復改善情形，以利後續輔導。

依專員分區就近分配主責輔導之出備醫院，以能即時提供評估人員有關個案評估、複雜個案處理、載具及系統操作等問題支援，以能順利銜接服務。

8. 發展原住民區、偏鄉及離島地區長照服務資源

（1） 社區式服務資源（不含團屋）布建策略及規劃

#	鄉鎮市區	推估 113 年長照需求人數 (A)	111 年 8 月		112 年		113 年	
			服務規模數(B)	涵蓋率 (B/A)	服務規模數(C)	涵蓋率 (C/A)	服務規模數(D)	涵蓋率 (D/A)
總計		1,042	120	11.5%	127	12.1%	130	12.4%
1	楠西區	350	30	8.6%	33	9.4%	36	10.29%
2	左鎮區	205	30	14.7%	30	14.7%	30	14.7%
3	龍崎區	168	30	17.8%	30	17.8%	30	17.8%
4	南化區	319	30	9.45%	34	10.66%	34	10.66%

【填寫說明】

1. 113 年長照需求人數=111 年 6 月老年人口數x13.3%失能率x至 113 年推估老年人口成長率。

2. 至113年老年人口成長率=113年推估老年人口（依國發會109年「中華民國人口推估(2020至2070年)」報告）÷111年6月老年人口數。

I. #1楠西區：112年預計布建服務規模計33人，含1家日照中心及1家托顧家庭。

A. 布建規劃及策略

本區目前已有1家日間照顧中心，可服務30人，預計運用托顧家庭輔導團隊開發潛能照顧服務員，培訓設置1家家托機構，以滿足需求。

B. 布建可能遭遇之困難事項

本案所屬區域範圍當地人口數較少，將影響照顧服務員設置托顧家庭意願。

C. 可能採行之因應措施

輔導在地照顧服務員轉型設置家托機構，並規劃偏區優先補助開辦費策略，減低開辦成本，以提高照顧服務員意願。

II. #4南化區：112年預計布建服務規模計34人，含1家日照中心及1家托顧家庭。

A. 布建規劃及策略

本區目前已有1家日間照顧中心，可服務30人，預計運用托顧家庭輔導團隊開發潛能照顧服務員，培訓設置1家家托機構，以滿足需求。

B. 布建可能遭遇之困難事項

本案所屬區域範圍當地人口數較少，將影響照顧服務員設置托顧家庭意願。

C. 可能採行之因應措施

輔導在地照顧服務員轉型設置家托機構，並規劃偏區優先補助開辦費策略，減低開辦成本，以提高照顧服務員意願。

（2） 提升社區式機構（不含團屋）使用率之服務概念翻轉策略

本市偏遠地區已設置4家社區式長照機構，目前平均服務使用率為85%，使用率未達80%者為南化區日照中心，為提升服務使用率，將持續由照管專員及A個管人員向偏遠地區民眾宣導社區式長照機構之優點，及高品質、多元化服務優勢，讓失能長輩及家屬了解居家式服務以外的另一選擇。

#	鄉鎮市區	111年8月			112年			113年		
		服務規模數(A)	使用人數(B)	涵蓋率(B/A)	服務規模數(C)	使用人數(D)	涵蓋率(D/C)	服務規模數(E)	使用人數(F)	涵蓋率(F/E)
總計		120	102	85%	127	113	89%	130	115	88%
1	楠西區	30	32	107%	33	32	97%	36	34	94%
2	左鎮區	30	25	83%	30	25	83%	30	25	83%
3	龍崎區	30	28	93%	30	28	93%	30	28	93%
4	南化區	30	17	57%	34	28	82%	34	28	82%

【填寫說明】各年度服務規模數應與上表相同。

1. 服務概念翻轉規劃及具體推動策略